

Endocrino

1. 1) 5 Causas de hipotiroidismo y causa mas frecuente, y su fisiopatogenia

Hashimoto (+ Frecuente)

Congénitos

Iodo 131

Auto inmune

Tumores

La tiroiditis de Hashimoto es la forma mas frecuente que produz hipotiroidismo, donde pro duz una destrucción del parénquima tiroideo.

2. 2) 5 Causas de tirotoxicosis y causa más frecuente y su fisiopatogenia.

Graves Basedow (+ frecuente) = Tirotoxicosis + Bocio + oftalmopatía + dermatopatía

Bocio Nodular

Bocio Multinodular

Plummer

Tiroiditis granulomatosa iatrogénica, farmacológica

Enf de Graves Basedow: Auto anticuerpo llamado TSI, se une al receptor de la TSH, y la estimula de forma constante, estimulando la liberación de hormonas tiroideas.

3. 3) Clasificación de Bocio según OMS.

Aumento del tamaño de la glándula tiroides que excede el tamaño de la falange terminal del dedo pulgar del paciente. (OMS)

0- No se palpa y no se ve

1-Se palpa pero no se ve

2-Se palpa y se ve.

4. 4) Clasificación de DBT. (DBT tipo I, DBT tipo II, DBT gestacional y otras)

5. 5) Criterio de DBT.

Glucosa en ayuna ≥ 126 mg/dl (x2)

Glucemia al azar ≥ 200 mg/dl (x1) + síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia) PTOG a las 2 Hs ≥ 200 mg/dl (x2)

6) FisiopatogêníadeDBTtipoI

Destrucción de las células B Del páncreas con una menor capacidad para producir y liberar insulina.

Presencia de anticuerpos anticitoplasmáticos (ACA) y anticuerpos anti-isletos (ICA), causa disminución de células secretoras de insulina (celb),
insulinitis, infiltración, LT mas macrófagos mas LB sin afectar la célula

7. 7) Objetivo de Tto para DBT:

niveles de glucosa en ayuna <100 hb

, TA, lípidos.

8. 8) 5 causas de hiperprolactinemia.

Embarazo

Hipopituitarismo

Prolactinoma

Farmacológico (- dopa = fenotiazidas) Cushing

Hipotiroidismo

9. 9) Causas de hipoinsulinismo.

10. 10) 5 Causas de lesión tumoral y no tumoral de la región selar-paraselar

11. 11) Multiple Choice: Streptococos: ¿quais eran? Glimepirida, gliberca...

12. 12) Causas de Hipoglucemia. (mezcla de 4 diferentes alt. de hormonas...)

13. 13) PQO: ¿qué causa?

Hiperandrogenismo, Hiperprolactinemia, Galactorrea,
Alt. Menstruales.

14. 14) Hormonas contrareguladoras (-insulina):

Glucagon, catecolaminas, cortisol,
GH.

15. 15) Est. Hiperosmolar: + frecuente en DBT I en ancianos, valores de osmolaridad y Ph.

16. 16) Varias sobre insuf. Supra renal primaria, Addison

17. Hiperaldosteronismo primario: ↑ aldosterona, ↓ renina, tb se ve ↓ K⁺, y Tto.

18. 18) DBT insípida causa central: SIADH

Síndrome de secreción inapropiada de ADH. Es cuando la osmolaridad está baja, y aun así sigue dando ADH.

Sínd. Hipotónico y hiponatremia

Clinica: Letargo, confusión, reflejos alterados, convulsiones, coma, astenia, debilidad, calambres.

19. 19) Hiperparatiroidismo:

20. 20) Hipogonadismo: ¿Qué es? Déficit de andrógenos gonadales.

21. 21) Varias tiroides: regulación, TSH y Yodo

22. 22) Bocio: Paciente con nódulo palpable, visible según clasificación de OMS que grado es ? 0, 1, 2, 3?

23. 23) Cretinismo endémico

Diferentes síndromes congénitos que tienen trastornos mentales, trast. Neurológico.

Retraso mental y retraso del crecimiento relacionado con hipotiroidismo, muchas veces por falta de yodo en la dieta de la gestante. El aporte de yodo a la madre en el tercer trimestre de la gestación, no previene trastornos neurológicos.

Posee dos formas de presentación: Neurológico y mixedematoso.

24. 25) ¿Qué deficiencias hormonales se tratan y hormonas faltantes? Hipotiroidismo

25. 26) Graves:

26. 27) Paciente con nódulo tiroideo ¿qué estudio? Gammagrafía, RNM y paaf.

28) Tiroiditis.

29) efecto incretina:

- La Glucosa VO produce mayor curva de insulina que cuando se administra por EV.
- Relacionado a hormonas del tracto GI que potencian la acción de la insulina.

1) Criterios y Tto de LES Criterios: + de 4

-Criterios: dx con 4 de 17 (mínimo un clínico y uno inmunológico)

Lupus cutáneo agudo

Úlceras orales

Alopecia na cicatrizante

Anemia hemolítica

Serositis

Leucopenia

Compromiso renal con prot >500mg/24h

convulsion

ANA positivo

Anti ADN positivo

Anti SM positivo

Complementos bajos

Coombs directo positivo

-Ttm: educación + aines + corticoides + antipalúdicos

Educación: protección solar, cese tabáquico, explicar al pct que el ttm puede ser de por vida

AINES: Diclofenac (NO ibuprofeno)

CORTICOIDES: prednisona

ANTIPALUDICOS: Hidroxicloroquina

Compromiso renal: Ciclofosfamida

2. 2) Lupos: Dx, clínica y Tto (Desde las inmunoglobulinas y significado)

El Dx se hace según la clínica y Maracadores inmunológicos:

- ANA(anticorpo antinuclear): presente en 95%, poco especifico
- Anti ADN(anti desoxirribonucleasa): asoc. daño renal y neurológico, marcador de actividad
- Anti sm (Smith): muy especifico de lupus, baja sensibilidad
- Ac antifosfolipidico: trant de la coagulacion
- Anti RO y Anti LA : contra proteínas nucleares y citoplasmáticas. Frec en LES subagudo, neonatalLES con ANA negativo.

3) Manifestaciones articulares de AR

- Metacarpofalangicas
- metatarsofalangica
- Interfalangicas proximales
- Respecta interfalange distal!!! Patron típico
- Rigidez matinal mayor a 1h
- Inicio gradual
- Patrón aditivo
- Desviación cubital
- Deformidad en dedos: cuello de cisne
- Tenosinovitis flexora

3. 4) Criteriosde AR: 4o+

-compromiso articular en grados

-inicio gradual

-afecctacion de articulaciones pequeñas

-poliartritis

-afectacion simétrica

-afectacion aditiva

-serologia positiva para FR

- serologia positiva para antiCCP
- rigidez matinal mayor a 1 hora
- duracion de los síntomas por mas de 6 semanas
- vsg elevada
- pcr elevado

5) Complicaciones extraarticular de AR

- Anemia crónica simples
- Derrame pleural
- Sdm caplan: AR + nodulosis pulmonar + neumoconiosis
- pericarditis
- Queratoconjuntivite seca
- Sind. De Felty: Artritis, Leucopenia, Esplenomegalia.
- Nódulos reumatoideos
- Glomerulonefritis mesangial

6. Rx de AR:

Alteración a partir de 6 meses de enfermedad no ttm

Pedir rx de apófisis estiloide cubital

- 1- Osteoporosis yuxtaarticular
- 2- Perdida de cartílago
- 3- Erosion marginal

7. Características comunes en espondiliartropatias

Compromiso axial sobre todo sacroiliaco

Compromiso periférico Asimetrico principalmente de miembros inferiores

Factor reumatoideo mayormente negativo

Ausencia de nódulos subcutáneos

Compromiso ocular frec

Asociación con el HLA B27

8. 7) Criterios de espondilitis anquilosante

dx: 1 clínico + 1 radiológico

- Limitación de la movilidad lumbar por al menos 3 meses que empeora con reposo y mejora con ejercicio
- Limitación de la movilidad de la columna lumbar en plano frontal (test de shoher, distancia dedo medio y piso, distancia occipusio pared)
- Diminución de la expansión torácica (prueba de expansión tx)
- Sacroileitis unilat grado 3 o 4
- Sacroileitis bilateral grado 2, 3 o 4

9. 8) Reiter: Todo lo que sabes

También llama de artritis reactiva, de una infección en los 3 meses anteriores (salmonella, clamidia)

La triada es: Sinovitis aséptica (siempre tiene que estar presente), conjuntivitis, uretritis

HLAB27 + en 80%

Monoartritis de rodilla, tobillo y MTF asociada a entesitis*

Tratamiento: suele ser una enf autolimitada, lo trato con AINEs y corticoides a bajas dosis para fase aguda

10. Artropatía psoriásica: síntomas y métodos de estudio?

Enf articular inflam asociada a psoriasis

Pedir: FR, Urea aumentada, Rx

HLAB27 solo en 25% de pct

Criterios: enf articular inflam + al menos 3 puntos

-evidencia de psoriasis o hist familiar

- FR negativo
- neoformacion yuxta-articular en rx (lesiones en lápiz y copa)
- distrofia ungueal psoriasica

11. 9) Clinica y Metodos de estudio de PAN.

Mediano calibre

Purpura palpable

Mononeuritis multiple: queja de pisando sobre huevos

Orquiepididimitis : dolor testicular

Ulcera

Gangrena

Glomerulonefritis pauciimune

Poliartalgia simétrica de grandes artc

Livedo reticularis

Dx:

Angiografía intestinal: microaneurismas

Biopsia cutánea de lesio

Vsg elevada

12. Vasculitis de wegner– Clinica y Tto

Granulomatosis con poliangeites

- compromiso de VAS : otitis media a repetición!, sinusitis a repetición!, pulmón con infiltrados nodulares con tendencia a cavitacion
- compromiso general: fatiga fiebre y decaimiento
- artromialgia

Afectacion de Senosparanasales+Pulmon+Rinon+ C-Anca

Lab: anca c

Tto:

- Corticoides • Metrotextato
- • Nodulos pulmonares
- • GN
- • Ocular
- • Artralgias/Artritis

12) Clinica y tto de polimialgia Reumatica

Dolor en el cuello y en la cintura escapular y pelviana de inicio SUBITO

Rigidez matutina.

Anemia, Anorexia y Perdida de Peso VSG elevada

El Tto se hace con Corticoides a dosis bajas.

13) Clinica y complicaciones de Esclerodermia.

-Clinica:

Engrosamiento cutáneo causado por acumulación excesiva de tejido conjuntivo. (Inflamacion, resolución)

Sistemica:

1. Con engrosamiento cutáneo difuso: progresión rápida, afectación visceral.
2. Con engrosamiento cutáneo Limitado: CREST = Calcinosis, Raynaud, Esofagitis, Esclerodactilia y Telangectasia.
3. Sind. Solapamiento: asociado a las demás enf. LES, AR...

Localizada:

1. Morfea
2. Esclerosis lineal
3. Fascitis eosinofílica.

Complicaciones:

14. 14) Miopatía Inflamatoria: clínica y tto.

Criterios:

- debilidad muscular proximal simétrica(hombros y cintura pélvica) PROGRESIVO de 3-6 meses de evol con poco o nada de dolor
- miositis en biopsia muscular
- enz musculares elevadas: cpk
- patron electromiografico característico
- rash cutaneo

Ttm:

- Corticoides a alta dosis : prednisona 1-2 mg/kg/d
- metotrexato: si no tiene contraindicaciones con alteración pulmonar

15. Definición, causas y Tto de Osteoporosis.

Desbalance entre formación e reabsorción ósea que predispone a las fracturas

Causas:

- hipoestrogenismo
- sedentarismo
- tabaquismo
- baja ingesta de calcio
- deficiencia de vit D

Dx:

Densitometría ósea: en raquis lumbar(evaluar L1 a L4) y cuello femoral del lado no habitual

-normal: +1 hasta -1

-osteoporosis: -2,5

Ttm: pedir estudio metabolismo fosfocálcico (Ca, P, Vit D, PTH, TSH,

Ejercicio

Exposición al sol

Farmacológico:

-Terapia de reemplazo hormonal en 2 primeros años posmenopausa

-Bifosfonatos: max 5 años

16. 17) Tto para Gota, aguda y crónica

17. Causas de monoartritis

Agudas:

-necrosis avascular

-artritis séptica + frec en joven

-artritis cristalinas (gota, pseudogota) + frec en ancianos

-traumática

Crónica:

-traumática

-osteoartritis: artrosis con trauma

-cristalina

-forma de comienzo de Seronegativa

-infecc cron: tbc

-sinovitis vellonodular

18. INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE TERAPIA BIOLOGICA

Indicaciones:

-Pacientes que no responden al menos a 2 DMARDs □ Uno de los cuales debe ser MTX

-Enfermedad activa (DAS 28: > 5,1 o sea severa o muy severa)

Contraindicaciones absolutas:

-Infecciones activas o latentes

-Enfermedad desmielinizante

-IC

-Antecedente de neoplasias en los últimos 5 años

-muy costoso